

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Pediátrica —

PACIENTE

Santiago Andrés Morales Castaño

DOCUMENTO

TI 1121000001

FECHA NACIMIENTO

15/10/2017

EDAD

8 años, 7 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

3° Primaria

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

04/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001234

PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV Evaluación Neuropsicológica Pediátrica

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Santiago Andrés Morales Castaño	Lateralidad:	Diestro
Documento:	TI 1121000001	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	15/10/2017	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	8 años, 7 meses	Acompañante:	Claudia Inés Castaño Pérez
Sexo:	Masculino	Remite:	Colegio San Marcos
Escolaridad:	3° Primaria	EPS / Asegurador:	Compensar EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Dificultades atencionales reportadas por la docente desde primer grado. Se distrae con facilidad, pierde objetos, no termina tareas a tiempo. Rendimiento académico descendente en los últimos 6 meses.

HISTORIA DEL DESARROLLO

Hitos relevantes en la trayectoria evolutiva

Perinatales y prenatales

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Trayectoria escolar

Estudios: 3° Primaria. Ocupación: Estudiante.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WISC-IV Evaluación Neuropsicológica Pediátrica

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Números y Letras	Memoria de Trabajo	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Aritmética	Memoria de Trabajo	—
Matrices	Razonamiento Perceptual	—
Comprensión	Comprensión Verbal	—
Búsqueda de símbolos	Velocidad de Proceso	—
Regresión Dígitos Directos	Memoria de Trabajo	—
Conceptos con Dibujos	Razonamiento Perceptual	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
Índice de Capacidad General (ICG)	Inteligencia General	—
CI total	Inteligencia General	—

ANTECEDENTES

Patológicos/ Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Durante la aplicación el niño requirió redirección constante. Tiempo en tarea máximo: 4-5 minutos. Utilizó estrategias compensatorias (tarjetas visuales) con eficacia parcial.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F90.0 - TDAH tipo inatento

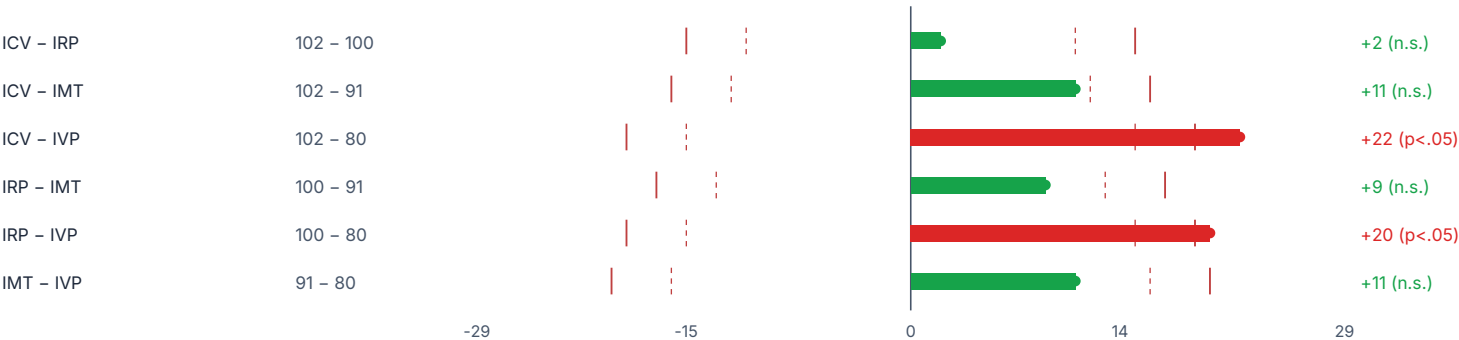
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

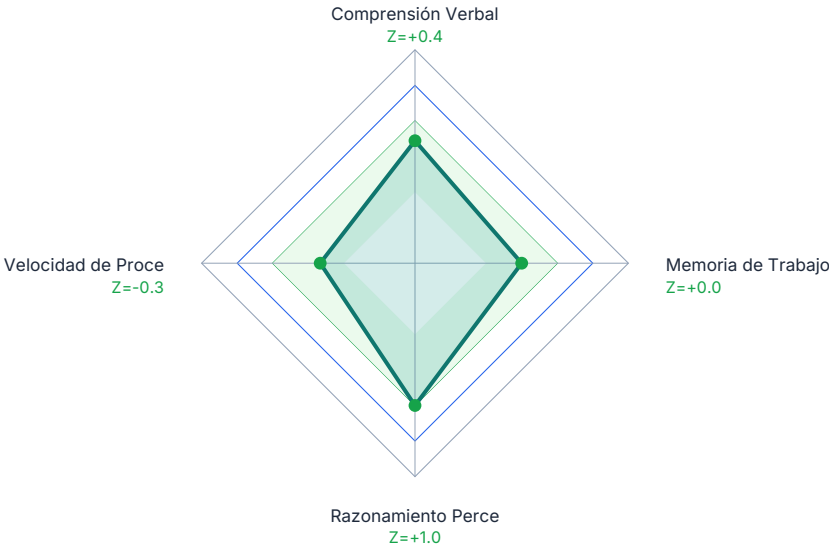


Discrepancias entre índices

Diferencia = valor del primer índice – segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p<.15$... y $p<.05$).

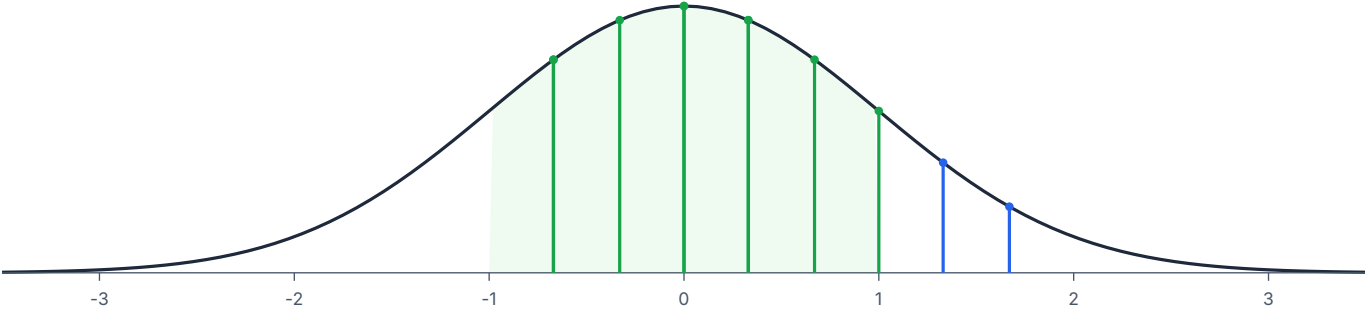


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 11 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							+0.33
Semejanzas							+1.33
Vocabulario							-0.33
Números y Letras							+0.67
Claves							-0.67
Aritmética							-0.67
Matrices							+1.00
Comprensión							+0.33
Búsqueda de símbolos							+0.00
Regresión Dígitos Directos							+0.00
Conceptos con Dibujos							+1.67
Ind Comp Verb							+0.13
Ind Raz Perce							+0.00
Ind Mem Trab							-0.60
Ind Vel Proce							-1.33
Índice de Capacidad General (ICG)							+2.60
CI total							-0.80

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	25	11	+0.33	Promedio
Semejanzas	22	14	+1.33	Superior
Vocabulario	24	9	-0.33	Promedio
Números y Letras	17	12	+0.67	Promedio
Claves	28	8	-0.67	Promedio
Aritmética	16	8	-0.67	Promedio
Matrices	22	13	+1.00	Superior
Comprensión	20	11	+0.33	Promedio
Búsqueda de símbolos	17	10	+0.00	Promedio
Regresión Dígitos Directos	13	10	+0.00	Promedio
Conceptos con Dibujos	21	15	+1.67	Superior
Ind Comp Verb	32	102	+0.13	Promedio
Ind Raz Perce	30	100	+0.00	Promedio
Ind Mem Trab	17	91	-0.60	Promedio
Ind Vel Proce	13	80	-1.33	Promedio
Índice de Capacidad General (ICG)	92	139	+2.60	Superior
CI total	85	88	-0.80	Promedio

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Santiago obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 88, ubicándose en la categoría promedio bajo (percentil aproximado 21). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IVP (80) y el más alto a ICV (102), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

Por su parte, destacan como áreas preservadas o por encima del promedio: razonamiento perceptual (alto, $Z=+1.0$).

Áreas con desempeño preservado / superior

- Conceptos con Dibujos — superior ($Z=+1.67$)
- Semejanzas — superior ($Z=+1.33$)
- Matrices — superior ($Z=+1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Santiago. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En NiWiscDC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWiscSem, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. En NiWiscVoc, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

Fortalezas (lo que se hace bien)

- En NiWiscDC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscSem, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En NiWiscVoc, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscLN, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscCI, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F90

Impresión diagnóstica: F90.0 - TDAH tipo inatento

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.